

Crupe (laringotraqueíte) · estridor

Crupe viral: tosse metálica, rouquidão e estridor inspiratório. Corticoide é a base; adrenalina nebulizada na obstrução moderada-grave.

Droga-chave

Dica - Droga-chave

Dexametasona 0,15–0,6 mg/kg (dose única; tetos conforme protocolo) reduz sintomas e retorno. Budesonida neb é alternativa se VO inviável.

Escore de Westley (conceito): estridor em repouso e retrações definem intensificação.



Diferenciais

- Epigloteite: toxemia, babão, posição em tripé — não examine a garganta à força
- Corpo estranho: início súbito sem pródrômo viral
- Abscesso retrofaríngeo: febre, cervicalgia, limitação
- Traqueíte bacteriana: piora tóxica após crupe

Conduta por gravidade

Nível | Conduta

Leve | Dexametasona; alta

Moderado | Dexametasona + adrenalina; observar 2–3 h

Grave | Adrenalina seriada + via aérea pronta

Rx (se feito) | Sinal do campanário — não obrigatório

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Após adrenalina, observe — efeito pode rebote. Não agite criança com estridor grave; O , suplementar e minimal handling.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

O Westley Croup Score (estridor, retração, entrada de ar, cianose, consciência) estratifica crupe e indica adrenalina nebulizada.

Somar: estridor, retração, entrada de ar, cianose e nível de consciência. Leve "d2; moderado 3–5; grave "e6 (cortes clássicos).

Westley Croup Score

Pontos por domínio

Estridor (nenhum / esforço / repouso)	0-2
Retração (nenhuma a grave)	0-3
Entrada de ar (normal a muito ↓)	0-2
Cianose (nenhuma / com esforço / repouso)	0-5
Consciência (normal / desorientado)	0-5

Leve <=2 | Moderado 3-5 | Grave >=6

Corticoide em todos os sintomáticos; adrenalina no moderado-grave com observação para rebote.

Crupe por Westley

Leve / moderado / grave

Leve

Westley <=2
Dexametasona VO
Alta orientada

Maioria

Moderado

Westley 3-5
Dexametasona
Adrenalina neb

Observar

Grave

Westley >=6
Adrenalina seriada
Via aérea / UTI

Emergência

Conduta

Nível | Conduta

Leve | Dexametasona 0,15–0,6 mg/kg; alta

Moderado | Dexametasona + adrenalina nebulizada; observar 2–3 h

Grave | Adrenalina seriada + via aérea pronta

Rx (se feito) | Sinal do campanário — não obrigatório

Diferenciais

- Epiglottite: toxemia, baba, tripé — não force exame de garganta
- Corpo estranho: início súbito sem pródromo
- Traqueíte bacteriana: piora tóxica após crupe
- Abscesso retrofaríngeo: febre + limitação cervical

Armadilha

Atencao - Armadilha

Após adrenalina, observe — pode haver rebote. Minimal handling na criança com estridor grave.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1